

Allégeons la charge anticholinergique des psychotropes !

🍬 Dans l'évaluation de la balance bénéfique/risque des médicaments psychotropes, il est essentiel d'avoir en tête la « charge » anticholinergique. Ces effets sont aussi appelés atropiniques, du nom de l'alcaloïde présent dans des plantes comme la belladone, qui doit son nom à la mydriase (dilatation de la pupille) induite par cette substance, supposée rendre le regard plus attractif.

🍬 L'effet anticholinergique est recherché quand on prescrit des « correcteurs » antiparkinsoniens pour diminuer les effets extra-pyramidaux (moteurs) des antipsychotiques.

🍬 La charge anticholinergique entraîne des effets indésirables « périphériques » (en dehors du système nerveux central)

☞ en diminuant la mobilité des muscles lisses du tube digestif

- constipation sévère/occlusion
- reflux gastro-oesophagien
- dysurie (difficultés à uriner)

☞ en diminuant les sécrétions

- sécheresse buccale (ne pas oublier d'aller chez le dentiste !)
- sécheresse oculaire, troubles de l'accommodation (vision floue)
- ↓ sudation (⚠ si canicule)

🍬 Des effets indésirables "centraux" peuvent aussi être observés, notamment chez les personnes âgées

☞ confusion avec désorientation temporo-spatiale

☞ apparition ou ↑ des déficits cognitifs

🍬 De nombreux psychotropes augmentent la charge anticholinergique, avec un effet cumulatif en cas de polythérapie

☞ **antipsychotiques**

- charge forte : clozapine (⚠ risque occlusif), levoméproméazine, cyamemazine, chlorpromazine, etc.
- charge modérée : olanzapine, loxapine, quetiapine

☞ **antiparkinsoniens (« correcteurs »)**

- charge forte : tous !! (tropatepine, trihexyphenidyl, biperiden)

☞ **antidépresseurs**

- charge forte : tous les tri- et tétracycliques (clomipramine, amitriptyline, etc.)
- charge modérée : paroxétine

☞ **anxiolytiques et hypnotiques**

- charge forte : hydroxyzine
- charge modérée : alimémazine

🔊 thymorégulateur

- charge modérée : carbamazépine

🧴 La charge anticholinergique expose aussi à

- 🧴 une diminution de l'observance et à un risque de rechute
- 🧴 une moindre efficacité de la réhabilitation psycho-sociale du fait des déficits cognitifs

🧴 Pour alléger la charge anticholinergique

- 🧴 diminuer (si possible) le nombre ou la dose des psychotropes à risque
- 🧴 évaluer l'utilité des antiparkinsoniens si ↓ doses d'antipsychotiques ou introduction de la clozapine (association le plus souvent non justifiée et à risque au niveau digestif)
- 🧴 limiter les prescriptions d'antipsychotiques sédatifs
- 🧴 ↑ de la charge avec les patchs de scopolamine pour l'hypersialorrhée ⚠️ : privilégier l'atropine par voie buccale
- 🧴 substituer par une molécule moins anticholinergique (par ex la paroxétine par un autre antidépresseur ISRS)
- 🧴 ne pas oublier les traitements anticholinergiques prescrits par d'autres collègues ou pris en automédication !

Références

<https://lnkd.in/dbg6u6G5>

<https://lnkd.in/d7SQfwpV>

<https://lnkd.in/dytCNBZZ>

